해오름손해사정㈜

SUNRISE SURVEYORS & CLAIMS ADJUSTERS CO., LTD.

국립암센터

의무기록사본

피보험자 : 이선아

의무기록사본 증명서

등록번호	33617857	발행번호	202539494
환 자 명	이선아	발 급 일	2025-12-05
용 도	보험회사	발행매수	13

본 의무기록사본 증명서와 첨부된 기록은 원본과 틀림이 없음을 증명합니다.

※ 본 사본의 누출, 위변조로 인한 훼손 피해 발생 시 책임은 본인에게 있습니다.
또한, 상기 용도 외에는 사용할 수 없으며, 사용용도 또는 사용기간이 완료된 후
즉시 파본, 폐기하여야 합니다.

국립암센터 NATIONAL CANCER CENTER

국 립 암 센 터 원 장

의무기록 사본문의 : (031) 920-0236
우 10408 경기도 고양시 일산동구 일산로 323번지(마두1동 809번지)

진 료 의 뢰 서

보험자기호		보험자명칭		의료보험증번호 (세대관리번호)	81503154073
보험자성명	이선아		주민등록번호		
수진자성명	이선아		주민등록번호	750218-2403115	
수진자주소	경기도 파주시 문산읍 우계로 470 102동 304호				
상 병 명	COLON POLYP====T-COLON R/O COLON CANCER			분류기호	
진료기간	~		진료구분	○입원	○외래
환자상태및 진료소견	2025-09-06일 본원에서 대장내시경 시행------T-COLON POLYP POLYPECTOMY 시행---조직검사상 ATYPICAL GLAND R/P COLON CANCER 소견나와 정밀 검사위해 전원하오니 고진선처바랍니다....				

발급일 2025-09-13

128-90-60331

담당의사 최지호 (서명 또는 날인) 면허번호 39761

최지호내과 최지호

요양기관지정번호 31368210

경기도 파주시 문산읍 문향로 72-1

명 칭 최지호내과의원, 내과

주: 1. 이 진료의뢰서는 1차진료후 2차진료를 받고자 하는 경우 1차 진료담당의사로부터 요양급여 기준에 따라 무상으로 교부됩니다.
2. 의사의 발급일부터 7일(공휴일 제외)이내에 사용하여야 합니다.
3. 환자상태 및 진료소견란에는 현증.검사.투약 등 주요진료내용을 구체적으로 기재하기 바라며 여백 부족시에는 뒷면을 활용하기 바랍니다.

의료법 제19조(비밀누설의 금지)에 근거하여 출력된 기록내용의 보안을 유지해야 할 책임이 있으며, 신청용도 외의 목적으로는 사용할 수 없습니다.

2025-12-05 12:45:48 출력자 : 장민지

▸등록번호: 33617857 ▸성명: 이선아 ▸성별/나이: 여 / 50

국립암센터 NATIONAL CANCER CENTER

외래초진 초진기록_자궁암 : 폐경클리닉 (2025-12-03)

주호소 >

1. MLH1 의 pathogenic variant

통증 : 무

소견 및 계획 >

현병력

--2--
LMP
PMP irregular

Colon CIS
s/p colon polypectomy

spotting (-)
9월 산부인과: 내막 두꺼워짐?

병력_개인력

Lynch syndrome
last PAP: 25.9

ROS (Review of system)

BSO recommended - strong (4-30%)

추정진단

EM calcification

계획

폐경 후 TLH, BSO 고려 하기로
6ML f/u
오셔서 피검사

여성생식기 초음파 표준판독지 >

1. 검사정보
검사명 : General sono(female genital)
검사방법 : 경질
검사자(면허번호) : 이동욱(66947)

2. 검사소견
자궁
자궁의 굴곡방향 : 전굴
이상 소견 : 없음
도플러 시행여부 : 아니오

자궁 내막
두께 : 7.0mm 이상소견 : EM calcification
도플러 시행여부 : 예 소견 : +

자궁 부속기
좌측 : 이상소견 (follicular cyst)
종물 크기 : 2.9 x 1.7cm
우측 : 정상
도플러 시행여부 : 아니오

더글라스와
액체 저류 : 없음

결론
소견 : EM calcification

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:44:45 의료정보관리실 장민지

이동옥 이동옥

외래초진 초진기록지_유방외과 : 유방암외과 **(2025-12-03)**

주호소 >
1. No chief complaint

통증 : 무

소견 및 계획 >

현병력

MLH1 의 pathogenic variant 로 내원하심.
6개월에 한번씩 연고지에서 sono
유방/겨드랑이 외(난소/자궁) 수술유무 : 없음
유방 수술 유무 : 없음

기타 병력_개인력
colon CIS
HTN

-모: 담도암 70세 진단, 아산병원에서 수술 진행함. 서울대에서 임상 시험으로 치료 중, 현재 75세임
자궁내막암
유방암 가족력 : 없음
임신 여부 : 무
유방암 외 가족력 : 조모, 모
월경력
초경나이 : 만 13-14세
폐경여부 : 폐경 전
출산력
출산자녀수 : 2명
수유방법 : 모유, 분유
투약사항
경구피임약 복용 : 없음
Hormone replacement therapy(HRT) : 없음

소견
opd sono both benign cyst, and benign lesion

ROS
NOS

Physical examination
non palpable

추정진단
Lynch syndrome

계획
연고지에서 현재 처럼 정기적으로 검진하시도록 설명

유방 초음파 판독지 >

외래 유방 초음파 검사 안함

이은경3 이은경

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:44:45 의료정보관리실 장민지

외래초진 초진기록지-외래공통 : (암예방)유전상담클리닉 (2025-11-04)

주호소 >

1. Genetic counselling
2. Family history of malignant neoplasm

통증 : 무

소견 및 계획 >

현병력

2025-09-29

Item	Result
Chromogranin	Negative
Synaptophysisn	Negative
CD56	Negative
hMLH1	Complete loss (0%)
hMSH2	Intact (80%)
hMSH6	Intact (85%)
hPMS2	Complete loss (0%)

2025-09-26
DIAGNOSIS:
#1. Colon, Transverse, ETC, Hot snare polypectomy:Healed ulcer with nonspecific inflammation
#2. Colon, Transverse, Polyp, IIa, Endoscopic mucosal resection:Adenocarcinoma

2025-09-23
DIAGNOSIS:
Colon, transverse, endoscopic polypectomy: Adenocarcinoma,

과거력/가족력/사회력

가족력
-모: 당도암 70세 진단, 아산병원에서 수술 진행함. 서울대에서 임상 시험으로 치료 중, 현재 75세임

기혼자

진단

2025.09 Colon cancer 50세 진단
R/O Lynch syndrome
R/O Hereditary cancer

계획

NGS hereditary cancer panel(73종)검사에 대해 충분히 설명 후 환자 선택하도록 함.
ROMA score검사.
상세 가계도 작성.
2주 후 유전 다학제 외래 예약.

[NCC2023-0179] 한국인 유전성암 환자 및 가족 코호트 구축
: 연구자는 NCC2023-0179 동의서 및 설명서 v1.8(02Dec2024) 충분히 설명 후 대상자는 충분한 질의 응답 시간을 갖고 충분한 심사숙고 후 동의하여 동의서에 자발적으로 자필 서명함. 사본 1부를 대상자에게 제공함. 인체 유래물 연구동의서 v1.1(06Jul2023)에 자필 서명함.

공선영

외래초진 초진기록지-외래공통 : 대장암외과 (2025-09-23)

주호소 >

1. T colon ca

통증 : 무

소견 및 계획 >

현병력
C/C
- T colon polyp (2025.9.7 at 최지호내과) => EMR with clipping => Bx ... ADC, WD, depth (?), uncertain resection margin

CVS Hx (-)

과거력/가족력/사회력
PHx
- OP Hx (-)
- HTN / DM / HBV (+/-/-) => medcation

FHx
- mother ... biliary ca

진단
T colon ca, R/O ECC, s/p EMR

계획
Outside slide review
CVS with sefdation,
CEA
CT check

한경수 한경수

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:44:45 의료정보관리실 장민지

▸등록번호: 33617857 ▸성명: 이선아 ▸성별/나이: 여 / 50 국립암센터 NATIONAL CANCER CENTER

외래경과 경과기록 : 대장암외과 (2025-11-18)

요약정보:
HNPCC

Proximal T colon T1 (at least MM, suggestive of SM invasion), s/p EMR (2025.9.7 at 최지호내과)
both margin involved
=> additional UEMR (2025.9.26 at NCC)
=> Bx .. healed ulcer with no tumor cell

mid T colon Tis (LP), s/p UEMR (2025.9.26)
Lateral uncheckable (endoscopically complete resection)
hMLH1 & hPMS2 ... complete loss

=> NGS 유전성 암 유전자 검사 결과
MLH1 유전자에서 Pathogenic Variant (PV)가 발견됨

O

<NGS 유전성 암 유전자 검사 결과>
POSITIVE
MLH1 유전자에서 Pathogenic Variant (PV)가 발견되었습니다.

- 결과해석:
MLH1에서 1758번째 위치한 염기가 중복되어 587번째 아미노산인 Methionine이 Histidine으로 치환되고 해석 틀이 변하여 그 후로 6번째 오는 아미노산이 stop codon으로 변경될 것으로 예상되는 Pathogenic Variant인 c.1758dup가 발견되었습니다. 이 변이는 일반 인구집단(gnomAD, KRGDB)에서 보고된 바 없는 매우 드문 변이로 Clinvar에서 Pathogenic으로 분류되어 있습니다(ID: 89879).

Clinical correlation 및 필요하다고 판단될 경우 가족검사가 권장됩니다.

P

HNPCC
T colon T1 ca, s/p EMR
T colon Tis, s/p EMR

CVS, CEA F/U POD #6M (2026.3)

한경수 한경수

외래경과 경과기록 : (암예방)유전상담클리닉 (2025-11-18)

S

2025.09 Colon cancer 50세 진단
R/O Lynch syndrome
R/O Hereditary cancer

O

2025-11-04
NGS-유전성 암 유전자 panel(73종)
: MLH1 c.1758dup (p.Met587HisfsTer6) PV+
CA125: 9U/mL
Human epididymis protein: 41.3pmol/L
ROMA (폐경전 < 7.4%): 4.7%
ROMA (폐경후 <25.3%): 6.8%

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:44:54 의료정보관리실 장민지

A

MLH1 c.1758dup 변이는 일반 인구집단(gnomAD, KRGDB)에서 보고된 바 없는 매우 드문 변이로 Clinvar에서 Pathogenic으로 분류되어 있습니다(ID: 89879).

P

MLH1 유전자의 Pathogenic variant가 있으며, 췌장암, 위암, 자궁내막암 등의 위험이 있음.
(암예방)소화기클리닉, 산부인과 진료 안내함.
자녀와 혈연관계인 직계가족의 유전자 검사가 필요하며 빠른 시일내에 방문하시도록 권유함.

공선영

외래경과 경과기록 : 대장암외과 (2025-10-10)

요약정보:
Proximal T colon T1 (at least MM, suggestive of SM invasion), s/p EMR (2025.9.7 at 최지호내과)
both margin involved
=> additional UEMR (2025.9.26 at NCC)
=> Bx .. healed ulcer with no tumor cell

mid T colon Tis (LP), s/p UEMR (2025.9.26)
Lateral uncheckable (endoscopically complete resection)
hLMH1 & hPMS2 ... complete loss

O

CVS on 2025.9.26
<Findings>
proximal T-colon, previous o/s polypectomy site => additional UEMR => Bx .. NS
mid T-colon, 2cm sized IIa polyp => EMR 시행 => Tis

<Pathologic findings>
Adenocarcinoma, poorly differentiated
1) Histologic grade: high
2) Tumor configuration: type 0-IIb
3) Size of tumor: 1.0x0.7cm
4) Extent of invasion: mucosa (lamina propria) (pTis)
5) Resection margins
a) lateral: uncheckable
b) deep: 0.8mm
6) Preexisting polyp at the site of carcinoma: not identified
7) Venous invasion: not identified
8) Angiolymphatic invasion: not identified
9) Perineural invasion: not identified
10) Intratumoral or peritumoral lymphocytic response: not identified
11) Tumor border: pushing
12) Tumor budding: not identified (no budding foci)
13) Tumor perforation: not applicable
14) Pathologic stage (AJCC 2018): pTis

<면역병리>
hLMH1 ... complete loss
hPMS2 ... complete loss

<Outside slide review>
Adenocarcinoma, well differentiated
1) Histologic grade: low
2) Tumor configuration: uncheckable (focal presence of tumor tissue)
3) Size of tumor: 0.15x0.1cm
4) Extent of invasion: at least muscularis mucosa (see note)
5) Resection margins
a) lateral: involved by tumor

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:44:54 의료정보관리실 장민지

b) deep: involved by tumor
6) Preexisting polyp at the site of carcinoma: not identified
7) Venous invasion: uncheckable
8) Angiolymphatic invasion: uncheckable
9) Perineural invasion: uncheckable
10) Pericolic or perirectal tumor deposit: not applicable
11) Intratumoral or peritumoral lymphocytic response: not identified
12) Tumor border: uncheckable
13) Tumor budding: uncheckable
14) Pathologic stage (AJCC 2018): (see note)
Note) 1. Submucosal invasion is suggestive. But accurate evaluation is impossible due to tangential cutting and incomplete resection.

2. 외부병원 슬라이드 판독으로 판독에 제한이 있습니다.

CEA on same day
=> 1.2

CT abdomen on same day
<Findings>
No visible mass or thickening of T-colon, but limited evaluation due to collapsed
No definite evidence of intra-abdominal metastasis

CT chest on same day
<Findings>
1. Small nodule in RML and tiny subfissural nodule in RLL. (#86, 117)
-> R/O benign.
2. Mild both apical fibrosis.

P
T colon T1 & Tis ca, double primary, s/p EMR
R/O Lynch syndrome

유전상담 클리닉 consult

한경수 한경수

▸등록번호: 33617857 ▸성명: 이선아 ▸성별/나이: 여 / 50

국립암센터 NATIONAL CANCER CENTER

병리검사결과

병리번호 : **PA250012096**
진료과/병동(의뢰처) : 대장암외과(외래) 의뢰일 : **2025.09.26**
임상소견 및 병력 :
검체채취일 : **2025-09-29** 검사일 : **2025-09-29** 판독일 : **2025-10-01**
검사명 : 면역병리검사
검체명 : **S 250017687/2**

면 역 화 학 검 사 보 고 서

채취부위: S25-17687 (2)

임상진단:

병리진단:

결과:

Item	Result
Chromogranin	Negative
Synaptophysisn	Negative
CD56	Negative
hMLH1	Complete loss (0%)
hMSH2	Intact (80%)
hMSH6	Intact (85%)
hPMS2	Complete loss (0%)

Summary:

판독의 : 장희진

서명의 : 장희진

병리검사결과

병리번호 : **S 250017687**
진료과/병동(의뢰처) : 대장암외과(외래) 의뢰일 : **2025.09.26**
임상소견 및 병력 :
검체채취일 : **2025-09-26** 검사일 : **2025-09-26** 판독일 : **2025-10-01**
검사명 : 외과병리검사
검체명 : **endo(colon)**
CLINICAL DIAGNOSIS : ETC, Polyp

받은 조직은 2부분임.

#1. 포르말린에 고정된 1개의 polypectomy 조직으로 크기는 0.9x0.8cm임.

#2. 포르말린에 고정된 1개의 polypectomy 조직으로 크기는 1.4x0.7cm임.

MICRO (2 HE)

DIAGNOSIS:

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:45:10 의료정보관리실 장민지

#1. Colon, Transverse, ETC, Hot snare polypectomy:

Healed ulcer
with nonspecific inflammation

#2. Colon, Transverse, Polyp, IIa, Endoscopic mucosal resection:

Adenocarcinoma, poorly differentiated
1) Histologic grade: high
2) Tumor configuration: type 0-IIb
3) Size of tumor: 1.0x0.7cm
4) Extent of invasion: mucosa (lamina propria) (pTis)
5) Resection margins
   a) lateral: uncheckable
   b) deep: 0.8mm
6) Preexisting polyp at the site of carcinoma: not identified
7) Venous invasion: not identified
8) Angiolymphatic invasion: not identified
9) Perineural invasion: not identified
10) Intratumoral or peritumoral lymphocytic response: not identified
11) Tumor border: pushing
12) Tumor budding: not identified (no budding foci)
13) Tumor perforation: not applicable
14) Pathologic stage (AJCC 2018): pTis

판독의 : 장희진

서명의 : 장희진

병리검사결과

병리번호 : **C 250004426**

진료과/병동(의뢰처) : 대장암외과(외래) 의뢰일 : **2025.09.23**

임상소견 및 병력 :

검체채취일 : **2025-09-23** 검사일 : **2025-09-23** 판독일 : **2025-09-29**

검사명 : 외부검사

검체명 : **slide 1**장

검체정보: slide 1장
병원정보: T&C Pathology, S25-174925
채 취 일: 2025. 9. 8

MICRO (1 HE)

DIAGNOSIS:
Colon, transverse, endoscopic polypectomy:

Adenocarcinoma, well differentiated
1) Histologic grade: low
2) Tumor configuration: uncheckable (focal presence of tumor tissue)
3) Size of tumor: 0.15x0.1cm
4) Extent of invasion: at least muscularis mucosa (see note)
5) Resection margins
   a) lateral: involved by tumor
   b) deep: involved by tumor
6) Preexisting polyp at the site of carcinoma: not identified
7) Venous invasion: uncheckable
8) Angiolymphatic invasion: uncheckable
9) Perineural invasion: uncheckable
10) Pericolic or perirectal tumor deposit: not applicable
11) Intratumoral or peritumoral lymphocytic response: not identified

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:45:10 의료정보관리실 장민지

12) Tumor border: uncheckable
13) Tumor budding: uncheckable
14) Pathologic stage (AJCC 2018): (see note)

Note) 1. Submucosal invasion is suggestive. But accurate evaluation is impossible due to tangential cutting and incomplete resection.

2. 외부병원 슬라이드 판독으로 판독에 제한이 있습니다.

판독의 : 장희진

서명의 : 장희진

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:45:10 의료정보관리실 장민지

▸등록번호: 33617857 ▸성명: 이선아 ▸성별/나이: 여 / 50

국립암센터 NATIONAL CANCER CENTER

[Mucosal Resection and Submucosal Resection(소독료포함)]
[(검사일자:2025-09-26)]

목적

검 사 명 ▶ Mucosal Resection and Submucosal Resection(소독료포함)
검사목적 ▶ 외부검사 확인
가 족 력 ▶ N/A
과 거 력 ▶ <1년 미만

전상태

수 면 제 ▶ Midazolam (4mg)
세 척 액 ▶ 하프렙산
청결정도 ▶ Good

소견

도달위치 ▶ Cecum (12min) (33sec)
총검사시간 ▶ 29min
직장수지검사,항문외부관찰 ▶ 유

Scopic Findings

#	위치	거리(cm)	종류	모양	크기	처치	합병증	합병증처치
1	Transverse colon		ETC	Hot snare polypectomy				
2	Transverse colon		Polyp	IIa	2cm	EMR		

검사요약 ▶ CVS upto cecum
proximal T-colon, previous o/s polypectomy site => 추가 hot snaring 시행
mid T-colon, 2cm sized IIa polyp => EMR 시행

결과

내시경 진단 ▶ R/O T-colon cancer , S/P) o/s polypectomy (추가 hot snaring 시행)
Colonic polyp (Polypectomy was done)
Complication ▶ None

판독의: 한경수 / 고선영
서명의: 한경수 한경수

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:45:17 의료정보관리실 장민지

▸등록번호: 33617857 ▸성명: 이선아 ▸성별/나이: 여 / 50

국립암센터 NATIONAL CANCER CENTER

[CT Chest (contrast)]
[(검사일시:2025-09-26 13:36) (판독일시:2025-09-29 09:39)]

소견

chest CT with enhancement
Colon CIS

1. Small nodule in RML and tiny subfissural nodule in RLL. (#86, 117)
 -> R/O benign.
2. Mild both apical fibrosis.
3. Refer to abdomen CT for upper abdomen.

결과

Refer to the report above.

판독의: 이은주

[CT Abdomen & Pelvis (contrast) - CO]
[(검사일시:2025-09-26 13:36) (판독일시:2025-10-02 11:21)]

소견

Clinical information:
T colon polyp (2025.9.7 at 최지호내과)
 -> EMR with clipping -> Bx ... ADC, WD, depth (?), uncertain resection margin

Findings:

No visible mass or thickening of T-colon, but limited evaluation due to collapsed
 Rec) Correlation with CFS
No significant enlarged pericolic or paraaortic LN
No abnormal focal lesion in the liver other abdominal solid organs
No ascites
*Refer to the chest CT report for the covered lower thorax.

결과

No visible mass or thickening of T-colon, but limited evaluation due to collapsed
 Rec) Correlation with CFS
No definite evidence of intra-abdominal metastasis

판독의: 김유성

서명의: 김유성 김유성

기록내용의 보안을 유지해야할 책임이 있으며,용도 외의 목적으로 사용불가<의료법 제19조> 출력:2025-12-05 12:45:23 의료정보관리실 장민지